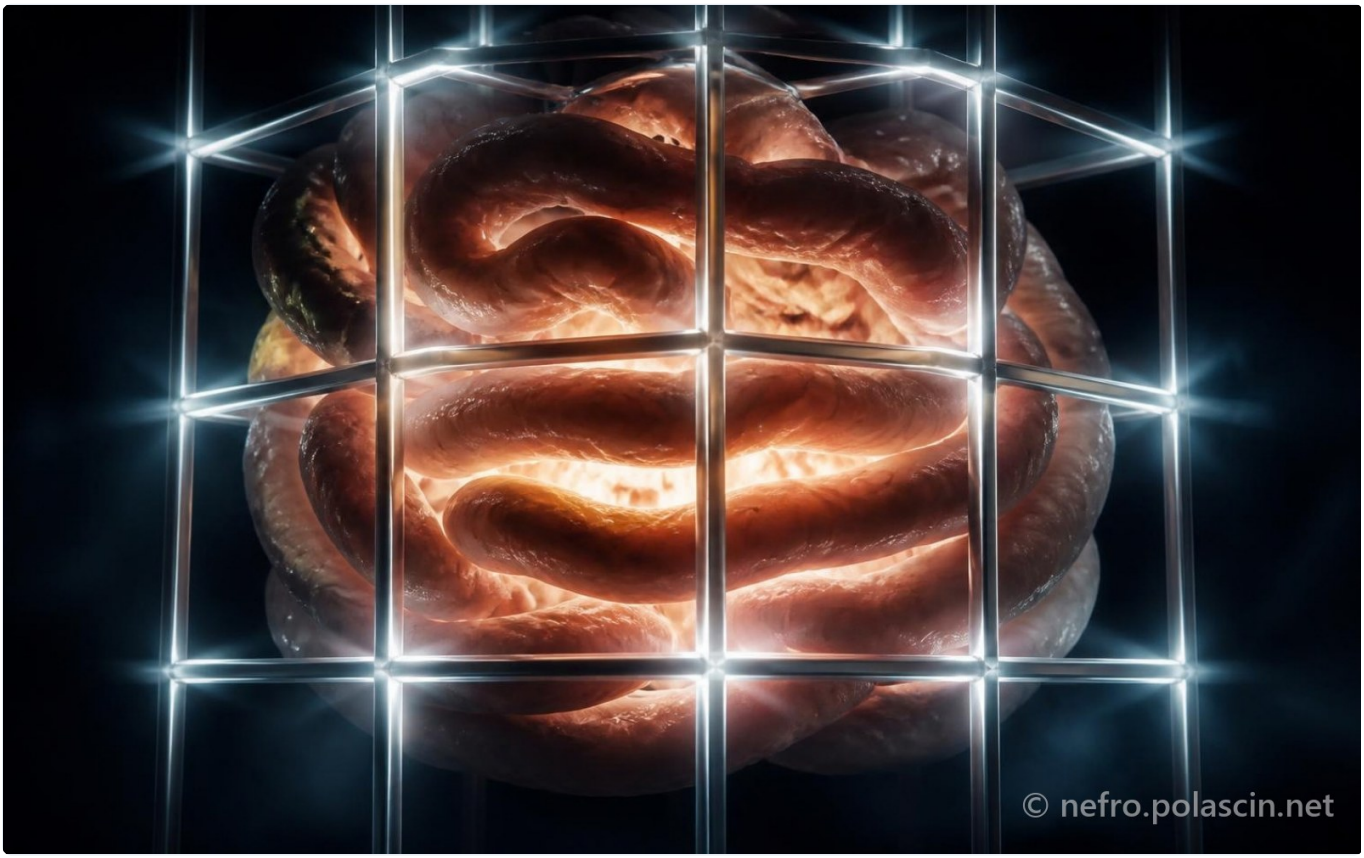
„Gutmaxxing“: keď sa snaha o zdravé črevo zmení na rigidný protokol a čo to znamená v nefrologickej ambulancii

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Keď sa zo starostlivosti o črevo stane nemenný protokol, obmedzenie začne škodiť skôr než pomáhať.

Pojmom „gutmaxxing“ sa v online komunitách označuje snaha o maximálne „optimalizované“ trávenie: vysoký príjem vlákniny a bielkovín, sledovanie makroživín, kombinácie výživových doplnkov, opakované „detoxikačné“ a „očistné“ cykly a vyraďovanie celých skupín potravín. Patrí k širšiemu javu, ktorý spája sebazlepšovanie s číselnými cieľmi. Pre ambulanciu nie je rozhodujúce ani tak to, čo pacient je, ako to, **ako prísne dodržiava pravidlá, ktoré si stanovil**. Pre pacienta s chronickou chorobou obličiek (CKD) sú tieto pravidlá spravidla prevzaté z odporúčaní, ktoré preňho neplatia.

Čo taký protokol zvyčajne obsahuje

- Číselné ciele pre bielkoviny a vlákninu, často prevzaté z fitness obsahu.
- Viacero výživových doplnkov naraz: probiotiká, vlákninové prípravky, proteínové koncentráty, kreatín, elektrolytové zmesi, bylinné prípravky.
- Vyraďovanie skupín potravín (lepok, mliečne výrobky, niektoré rastlinné oleje, väčšina ovocia) bez preukázanej intolerancie alebo alergie.
- Opakované „očistné“ režimy a preplachy.
- Denné vykazovanie a kontrola dodržiavania pravidiel.

Prečo je to nefrologická téma

Nefrológ sa s týmto javom stretáva v troch podobách. Prvou je pacient s CKD, ktorý si našiel „zdravý“ režim a nepovažuje ho za niečo, čo by mal v ambulancii spomenúť. Druhou je mladý pacient bez známeho ochorenia obličiek, ktorý prichádza s náhodne zisteným zvýšeným kreatinínom. Treťou je pacient, u ktorého sa za nutričným protokolom skrýva porucha príjmu potravy.

Cieľové hodnoty pre bežnú populáciu nie sú cieľovými hodnotami pri CKD

Toto je prakticky najdôležitejšia časť článku. Hodnoty, ktoré populárne prehľady uvádzajú ako rozumné, sú pri CKD nad odporúčaným stropom:

Situácia	Príjem bielkovín	Poznámka
Aktívny dospelý bez ochorenia obličiek	Bežne uvádzané rozpätie približne 1,2 – 1,6 g/kg/deň	Populárne zdroje zároveň odrádzajú od dlhodobého prekračovania 2 g/kg/deň.
CKD G3 – G5 bez dialýzy	**0,8 g/kg/deň**	Odporúčanie KDIGO 2024; pri riziku progresie sa **neodporúča prekračovať 1,3 g/kg/deň**.
Pacient na dialýze	Vyšší príjem než pri CKD bez dialýzy	Riziko je opačné: podvýživa a úbytok svalovej hmoty. Cieľ určuje nefrológ spolu s nutričným terapeutom.

Rozdiel je zásadný. Cieľ 1,6 g/kg/deň prevzatý z fitness obsahu leží u pacienta s CKD nad hranicou, ktorú KDIGO neodporúča prekračovať. U 80-kilogramového pacienta ide o rozdiel medzi približne 64 g a 128 g bielkovín denne. Podrobnejšie sa tejto otázke venuje samostatný článok o mýtoch influencerov (odkaz nižšie).

Doplnky výživy a minerálový profil

Pri CKD „prírodné“ neznamená „bezpečné“. Kombinované suplementačné režimy nesú tieto praktické riziká:

- **Draslík.** Rastlinné proteínové zmesi, zeleninové koncentráty a elektrolytové prípravky môžu obsahovať významné množstvo draslíka bez toho, aby to bolo zjavné z obalu.
- **Fosfor.** Fosforečnanové aditíva v spracovaných „proteínových“ výrobkoch sa vstrebávajú podstatne lepšie než fosfor viazaný v prirodzených potravinách.
- **Tekutiny a objem.** Vlákninové prípravky vyžadujú dostatočný príjem tekutín, ktorý je pri pokročilej CKD alebo pri srdcovom zlyhávaní obmedzený. „Očistné“ režimy zasa môžu viesť k stratám tekutín a k prerenálnemu poškodeniu.
- **Bylinné prípravky.** Časť z nich je nefrotoxická alebo vstupuje do liekových interakcií; zloženie výživových doplnkov nepodlieha rovnakej kontrole ako zloženie liekov.

Interpretácia kreatinínu

Vysoký príjem bielkovín, doplnky s kreatínom a vyšší podiel svalovej hmoty zvyšujú koncentráciu kreatinínu bez toho, aby klesla skutočná filtrácia. U pacienta s takýmto režimom je preto pred záverom o „zhoršení funkcie obličiek“ namieste doplniť cystatín C, prípadne albuminúriu, a odber zopakovať po vysadení doplnkov.

Kedy ide už o poruchu, nie o disciplínu

Hranica medzi starostlivosťou o zdravie a patologickým vzorcom nie je v obsahu diéty, ale v jej rigidite a v tom, čo sa stane pri jej porušení. Varovné signály:

- výrazná úzkosť, vina alebo pocit zlyhania pri odchýlke od protokolu,
- vyhýbanie sa spoločným jedlám, cestovaniu alebo rodinným udalostiam kvôli pravidlám,
- postupné rozširovanie zoznamu zakázaných potravín bez klinického dôvodu,
- opakované kontrolné správanie – váženie, fotografovanie, zapisovanie, vyhľadávanie zloženia,
- neúmyselné chudnutie, únava, výpadok menštruácie, znížená výkonnosť,
- presvedčenie, ktoré odoláva vysvetleniu a opiera sa o obsah zo sociálnych sietí.

Poznámka k terminológii: pojem „ortorexia“ sa v tejto súvislosti používa často, **nejde však o samostatnú diagnostickú jednotku v DSM-5**. Klinicky významné je to, či sú prítomné kritériá poruchy príjmu potravy (najmä vyhýbavo-reštriktívnej poruchy príjmu potravy) alebo obsedantno-kompulzívneho okruhu. Pri podozrení patrí pacient k psychiatrovi alebo klinickému psychológovi, nie k ďalšej nutričnej úprave.

Praktický postup v ambulancii

1. **Pýtať sa cielene.** Otázka „dodržiavate nejakú diétu?“ často nestačí. Konkrétnejšie: „Máte nejaké pravidlá, čo môžete a čo nemôžete jesť? Čo sa stane, keď ich nedodržíte?“
2. **Vypísať všetky doplnky.** Vrátane proteínových práškov, elektrolytových zmesí, bylinných čajov a „očistných“ prípravkov. Pacienti ich spravidla neuvádzajú medzi liekmi.
3. **Prepočítať skutočný príjem bielkovín** na kilogram telesnej hmotnosti a porovnať ho s cieľom primeraným štádiu CKD, nie s cieľom z internetu.
4. **Zvážiť laboratórne vyšetrenie** podľa klinickej situácie: kálium, fosfor, vápnik, bikarbonát, kreatinín s cystatínom C, albuminúria, prípadne parametre nutričného stavu.
5. **Nezakazovať plošne.** Zákaz bez vysvetlenia motivovaného pacienta spravidla nezastaví; pacient len prestane lekára o režime informovať. Účinnejšie je ponúknuť konkrétny, číselne vyjadrený cieľ prispôsobený jeho štádiu CKD.
6. **Vlákninu preferovať z potravy.** Pri CKD však treba zohľadniť obsah draslíka v jednotlivých zdrojoch a prípadné obmedzenie príjmu tekutín.

Čo z tejto témy netreba preháňať

Nejde o doložený nefrologický rizikový faktor s vlastnou epidemiológiou. Neexistujú údaje o tom, koľko pacientov s CKD takýto režim dodržiava, ani štúdie o jeho vplyve na progresiu ochorenia obličiek. Tvrdiť, že „gutmaxxing poškodzuje obličky“, by bolo rovnakým typom nepodloženého zjednodušenia, aké sa vyčíta samotnému trendu. Doložené je niečo iné a skromnejšie: **pri CKD sú vysoký príjem bielkovín, nekontrolované doplnky a očistné režimy rizikové**, a rigidný protokol prevzatý zo sociálnych sietí je spoľahlivá cesta ku všetkým trom naraz.

Záver

„Gutmaxxing“ je príklad toho, ako sa zdravotná motivácia mení na číselný protokol. Pre nefrológa z toho vyplývajú dve úlohy: preložiť cieľové hodnoty do podoby platnej pre dané štádium CKD (najmä pri bielkovinách, kde sa bežne odporúčané rozpätie s odporúčaním KDIGO míňa) a rozpoznať, kedy už za protokolom nestojí disciplína, ale porucha, ktorá si vyžaduje inú než nutričnú intervenciu.

Súvisiace články

- Strava a zdravie čreva podľa influencerov: kde vznikajú najčastejšie chyby
- Proteín a kreatín už nie sú výhradne „fitness téma“ a čo z toho plynie pre nefrológiu
- Mierne obmedzenie bielkovín môže pri chronickej chorobe obličiek zlepšiť prognózu
- Kreatín pri ochoreniach obličiek: bezpečnosť a prínos
- Kontrola draslíka pri CKD: edukovať, nie strašiť

Odborné zdroje

1. Východiskový materiál: *Medscape. Gutmaxxing: Online Trend, Real-World GI Implications. 2026. Naratívny klinický komentár; autorstvo nie je v dostupnej časti materiálu jednoznačne uvedené, preto sa v tomto článku neuvádza. Odborné prahy a nefrologické súvislosti boli doplnené a overené podľa zdrojov nižšie.*

2. Odporúčanie pre príjem bielkovín pri CKD: *Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4 Suppl):S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. Zdroj odporúčania 0,8 g/kg/deň pri CKD G3–G5 a praktického bodu o hranici 1,3 g/kg/deň pri riziku progresie.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Číselné prahy pre príjem bielkovín pri CKD boli overené podľa odporúčania KDIGO 2024; rozpätia uvádzané pre bežnú populáciu pochádzajú z východiskového materiálu a platia pre osoby bez ochorenia obličiek. Údaje o prevalencii tohto správania medzi pacientmi s CKD ani o jeho vplyve na progresiu ochorenia obličiek nie sú k dispozícii a článok ich neuvádza. Klasifikácia varovných znakov porúch príjmu potravy je uvedená ako orientačná; diagnostiku vykonáva psychiater alebo klinický psychológ.*

Text má odborný informačný charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ani nutričné poradenstvo prispôsobené konkrétnemu pacientovi a štádiu ochorenia obličiek.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=gutmaxxing-rigidny-dietny-protokol-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.